

	IMPRESIÓN DE HISTORIA CLÍNICA PSICOLOGÍA	
	Historia # 00002	Fecha De Impresión: 26-05-2025 12:32:17

Datos Personales							
Nombre:	JUAN MANUEL MARÍN CAMPO	Sexo Biológ.:	H	F. Nacimiento:	2011-12-19	Edad	13 Años, 5 Meses, Y 7 Días
Identificación:	TI - 1066290502	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	MCAMCAN1013@GMAIL.COM - 1066290502			Dirección:	MZ 4 CASA 41 URB. RAFAEL ESCALONA		
Departamento:	CESAR	Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana	
Empresa:	ESS024 - (COOSALUD EPS-S)						
En Caso De Emergencia Llamar A:		MELBA ALICIA CAMPO CANTILLO - Parentesco (madre) - Teléfono (3124366207)					

Apertura psicología del 2025-05-20 12:07:15: 13 años, 5 meses, y 7 días

DATOS GENERALES
Remisión Particular
DX principal F845 - SINDROME DE ASPERGER
Código de consulta 890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA
Motivo de Consulta Padres reportan que Juan Manuel es un niño con altas capacidades cognitivas y facilidad para adaptarse en algunos lugares. Sin embargo, presentan inquietudes en torno a su regulación emocional, habilidades motrices finas (no sabe amarrarse muy bien los cordones de los zapatos y no le gusta mucho escribir) y desempeño en la interacción social. Refieren sensibilidad a estímulos sensoriales como el ruido, preferencia por interactuar con niños menores o con intereses similares, conductas motoras repetitivas y dificultad para gestionar la frustración, así como episodios de desconexión atencional. También se nota rígido al saludar y poco empatico.
Enfermedad Actual Paciente con inicio de sintomatología posterior a los 4 años, tras un periodo prolongado de aislamiento social debido al confinamiento por COVID-19. Presenta dificultades persistentes en la interacción social, ansiedad en contextos con multitudes, rigidez al momento de saludar y bajo nivel de empatía, intereses restringidos centrados en temas científicos y escasa flexibilidad conversacional. Se observan estereotipias motoras manuales, hipersensibilidad auditiva y táctil, así como dificultades en la integración escolar, especialmente en actividades grupales. A nivel del lenguaje, se identifican dislalia (rotacismo), disprosodia, escritura acelerada con inversión de grafemas, distractibilidad y baja tolerancia a tareas no motivantes. Presenta un sentido rígido de la norma y la moral, con rechazo marcado hacia conductas o contenidos que percibe como inadecuados o incorrectos.

ANTECEDENTES	
Médicos Personales	
Quirúrgico No Refiere	Tóxicos No Refiere
Traumáticos Otro	Medicación No Refiere
Paraclínicos Si	Hospitalizaciones Si
Patología Asmático, Sindactilia Al Momento De Nacer.	

ANTECEDENTES	
Prenatales	
Enfermedades De La Madre No	Único Embarazo 2do
El Embarazo Fue Controlado Por Atención Médica Si	Uso De Planificación En El Momento Del Embarazo Si
Estado De La Madre Durante El Embarazo Embarazo Con Riesgo, Estados Emocionales Regulados, Sin Enfermedades Medicas	

ANTECEDENTES
Natales

Tipo De Nacimiento Cesarea	Causa De La Cesárea Signos De Plecamsia
Uso De Maniobras De Reanimación No	Peso Al Nacer 4400 Kg
Talla Al Nacer 52 Cm	Lianto Al Nacer Si

ANTECEDENTES
Posnatales

Hospitalizaciones Recién Nacido
Nació Con Sindactilia – Le Hicieron Cirugía Al Momento De Nacer.

ANTECEDENTES
Desarrollo Psicomotor

Control Cefálico 1 M	Rolado 3 M
Sedente Solo 4 M	Gateo 5 M
Bípedo Sin Ayuda 11 M	Marcha 12 M
Lenguaje Verbal 18 M	Lenguaje Verbal Fluido 6 AÑOS

ANTECEDENTES
Médicos Familiares

Depresión No Refiere	Ansiedad No Refiere
Demencia No Refiere	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos Prima Con Esquizofrenia	Otros No Refiere

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa

El paciente se encuentra actualmente cursando octavo grado. Aunque el cuerpo docente ha considerado la posibilidad de promoverlo anticipadamente, los padres han optado por mantenerlo en el nivel actual. Presenta un rendimiento académico elevado, a pesar de mostrar escasa motivación hacia las tareas escritas. Destaca por su precisión en los detalles, así como por sus habilidades superiores en codificación, decodificación y recuperación de información. En ocasiones presenta dificultades en la comunicación interpersonal con figuras de autoridad, ya que expresa sus opiniones de manera directa, sin filtros sociales, lo que puede interpretarse como falta de asertividad. Posee un nivel de conocimiento general por encima del promedio.

Historia laboral

No refiere

Historia familiar

Actualmente vive con la Mamá la Señora Melba Campo con años, el papá el señor Janer Junior Marín Abello, la hermana mayor la señorita Veronica Dayanna Marín Campo y la hermana menor la señorita Victoria Marín Campo. basada en la entrevista Psicológica mantienen una buen relación familiar, con establecimiento de limites con amor y normas en el hogar.

Historia social

El paciente pertenece a un núcleo familiar funcional, con cuidadores comprometidos en su proceso formativo. Ha contado con un ambiente estructurado, aunque con antecedentes de aislamiento social prolongado durante los primeros años debido al confinamiento por COVID-19. Actualmente asiste a una institución educativa formal y cuenta con acceso a recursos académicos y tecnológicos. El entorno familiar muestra interés en su bienestar, aunque con tendencias a la rigidez y a decisiones conservadoras frente a su avance escolar.

Historia socio-afectiva

Se evidencian dificultades en la interacción con pares, con preferencia por actividades individuales o con personas que compartan sus intereses restringidos. Presenta escasa flexibilidad emocional, rigidez conductual y baja empatía, con comunicación poco modulada y tendencia a la literalidad. Las expresiones afectivas resultan limitadas en contextos sociales, y se observa un fuerte sentido de normatividad y justicia, lo que puede generar fricciones en relaciones interpersonales y con figuras de autoridad.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica

No refiere

Intervención neurológica

No refiere

Intervención neuropsicológica

Intervención con pruebas Neuropsicológicas los días a,5,6/02/2025 y entrega de Informe clínico con una impresión diagnóstica "F845 SÍNDROME DE ASPERGER (Trastorno del espectro del autismo grado 1), acompañado de: (problemas en la escritura, problemas en la expresión del lenguaje y comportamiento). CIT DE 125, CAPACIDAD GENERAL INTELECTUAL SUPERIOR, (altas capacidades)". Concluye el infome con el perfil "De acuerdo a la evaluación neuropsicológica, exploración realizada, la observación directa e historia clínica, se establece un perfil cognitivo superior de 125, con tendencia al crecimiento de pasar a muy superior (de 130 en adelante), acompañado de perfil de síndrome asperger (clasificación CIE 10) o trastorno del espectro del autismo grado 1 (clasificación DSM 5), con afectación en las áreas de comunicación social e interacción recíproca, patrón de comportamiento restrictivo o repetitivo, con comportamientos de angustia (tendencia a estar en crisis por situaciones que no los justifican pero que son de gran repercusión emocional para nuestro paciente lo cual constituye un objeto de atención clínica)". Dr. Jainer Guzman Vega.

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

Paciente ingresa a consulta en compañía con la mamá la señora Melba Campo, con saludo rígido, se observa orientado auto y alopsiquicamente, presentación personal acorde al contexto, inadecuada higiene postural, alerta, receptivo, poco contacto visual, verborreico, inteligencia aparentemente normal, pensmaiento logico, niega pensamientos suicidas y coopera en la entrevista psicológica.

Ciclos del Sueño

Conservados.

Apetito

Conservado.

Actividades de Autocuidado

Independiente.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V):

F845 - SINDROME DE ASPERGER

Establecido por primera vez

Si

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención

Objetivo General

Promover la adaptación funcional, emocional y social en los contextos escolar, familiar y comunitario.

Objetivos Específicos

- Evaluar intereses y motivaciones específicas para planear intervenciones significativas.
- Entrevistas semiestructuradas con los padres.
- Desarrollar habilidades sociales básicas y complejas mediante estrategias estructuradas. (modelado, juego de roles, retroalimentación, historias sociales para preparar situaciones nuevas o conflictivas, urnos, cómo unirse a un juego).
- Identificación y anticipación de situaciones desencadenantes.
- Entrenamiento en regulación emocional (definición de emociones, tarjetas visuales, caja de herramientas sensorial).
- Estimular la fluidez verbal, la empatía y la asertividad comunicativa.
- Rutinas de relajación (respiración, mindfulness adaptado).
- Generar un entorno comprensivo, predecible y estructurado en el hogar con los familiare o red de apoyo cercana.

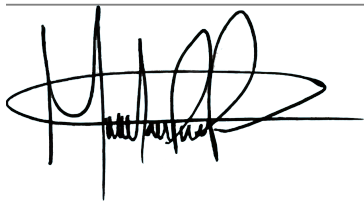
Sugerencias e Interconsultas

Interconsulta con Terapia Ocupacional.

Observaciones y Recomendaciones

- Iniciar terapia por Psicología clínica (1 vez por semana, durante 3 meses).
- **Realizar ajustes y modificaciones al currículo escolar:** Implementar un Plan Individual de Apoyos y Ajustes Razonables (PIAR), conforme a la normativa vigente [Art. 2.3.3.5.2.3.5], con el fin de facilitar el desarrollo académico del estudiante, y aumentar su interés y participación en los procesos de aprendizaje.
- **Usar estrategias de evaluación flexibles:** Evaluar los conocimientos y avances del estudiante mediante métodos alternativos (como talleres, exposiciones, preguntas orales o ejercicios prácticos) que respondan a sus capacidades individuales y no solo a los estándares del grupo.
- **Promover la comprensión y empatía del grupo:** Informar a sus compañeros que necesita menos ruido para concentrarse y brindarles una explicación sencilla sobre algunas de sus particularidades para fomentar la inclusión y la sensibilidad social.
- **No tomar su comportamiento como algo personal:** Reconocer que está en proceso de aprendizaje en cuanto al control de impulsos y la comunicación adecuada. Necesita guía, no castigo.

- **Anticipar los cambios:** Informar con antelación si habrá modificaciones en la rutina o actividades especiales, especialmente si hay presencia de muchas personas o estímulos nuevos que podrían alterarlo.
- **Reforzar los comportamientos adecuados:** Aumentar la frecuencia de elogios, recompensas y reconocimiento positivo cuando se logren avances, incluso pequeños.
- **Facilitar interacciones con sus pares:** Fomentar su integración al grupo mediante un pequeño equipo de compañeros empáticos que lo incluyan en actividades y modelen habilidades sociales.
- **Fomentar el contacto visual, sin forzarlo:** Invitarlo amablemente a mirar al interlocutor, respetando sus límites y tiempos.
- **Tratarlo con respeto y empatía:** Recordar siempre que merece un trato digno, con paciencia, ternura y respeto por su estilo de aprendizaje.
- **Tener paciencia con su forma de responder:** Puede demorar en contestar o dar respuestas muy largas y detalladas. Ayúdelo con ejemplos concretos para orientar su respuesta.
- **Ayudarle a evitar la escalada emocional:** Si se altera, acompañelo con firmeza y cariño para retirarse del estímulo que lo sobrecarga.



DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica

Tarjeta Profesional: 259542